



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN IV
KOMITE PPRA
BULAN OKTOBER - DESEMBER
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Triwulan IV Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sehingga dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika).

Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba dilakukan berdasarkan tersedianya data audit penggunaan antibiotik. Data yang tersedia yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling berkesinambungan untuk dapat menilai apakah penggunaan antibiotik Rumah Sakit sudah tergolong rasional atau tidak. Hasil audit kuantitatif dan kualitatif dapat dijadikan penilaian terhadap seluruh SMF terkait pemberian antibiotik didasarkan pada PPAB (Panduan Penggunaan Antibiotik).

Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

I. SDM

Jumlah SDM bulan ini:

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	Oktober – Desember	Kebutuhan	
Ketua PPRA	1	1	0	
Sekretaris	1	1	0	
Anggota	31	29	2	

II. Pemenuhan kualifikasi SDM:

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan	Keterangan
		Standar	Kondisi saat ini		
Ketua	dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.	S1	Sp 1 pediatrik	Pelatihan PPRA eksternal	Belum terlaksana
Sekretaris	apt. Rifdah Bunga K S.Farm.	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
Anggota	dr. Ari Putriani, Sp.PK	S1	Dokter Patologi Klinik	Pelatihan PPRA eksternal	Terlaksana
	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Ardhi Bustami, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Belum Terlaksana
	dr. Antonius Setiadi, Sp. B	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Iwan Donosepoetr o, Sp. B.FINACS	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Heriyatmo, Sp.Pd	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Ira Setya, Sp. JP	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Dewi Maharani, Sp. S	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Titok, Sp. M	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Aida M., Sp. OG	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Andy, Sp. P	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Pradana Nurhadi, Sp. U	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Arianto, Sp. OT	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Nimim , Sp. KK	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Rino R.	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

	dr. Nur Mazidah	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Yuanita Eka L, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Asharul Fahrizi, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Ica Anindya Pangestika, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Guspa Gayatri A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Fadilah Maulana Ihram A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	ns. Very Susanto, S. Kep	S1	S1 Ners	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	ns. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep	S1	S1 Ners	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Kep	S1/D3	Bidan	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Sherly Rosita, Amd. Kep.	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Trikaya Inggar Yuniar, Amd. Kep	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

III. PROGRAM KERJA DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Hasil	Ket.
1	Pembuatan Pedoman Penggunaan Antibiotika RS	Tidak ada pembaharuan Pedoman Penggunaan Antibiotik (PPAB)	Pedoman penggunaan antibiotik yang ada masih relevan untuk di gunakan
2	Sosialisasi PPRA	Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang PPRA tahun 2025	
3	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Antibiotika	Rapat untuk membahas tentang pengumpulan data penggunaan antibiotika di RS Prima Husada	Laporan triwulan

IV. FASILITAS

No	Kegiatan Pokok	Ket.
1	Ruang Komite PPRA	Mengajukan ke pihak manajemen, belum ada realisasi

V. INDIKATOR MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA

No	Indikator Mutu	Standar
1	Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada	-
2	Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)	≥50%
3	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025	-
4	Audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif	-

VI. PENCAPAIAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA TRIWULAN IV

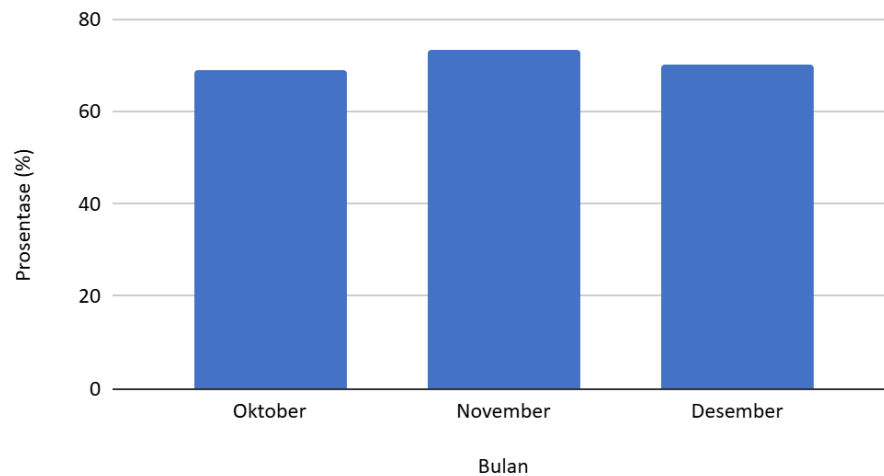
1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada

a. Tabel Surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

No	Bulan	Prosentase (%)
1	Oktober	69,04
2	November	73,34
3	Desember	70,23

b. Grafik surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

Surveilans Penggunaan Antibiotik



c. Analisa surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

- Pengambilan data diambil dari SIMRS
- Penggunaan antibiotik tertinggi pada bulan November sebesar 73,34 %, pada bulan Desember sebesar 70,23 %, dan pada bulan Oktober sebesar 69,04 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik lebih dari target (>50%).

d. Rencana tindak lanjut

- Dilakukan sosialisasi masiv terkait penggunaan antibiotik bijak dan rasional terhadap DPJP.
- Dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi terkait penggunaan antibiotik.

2. Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

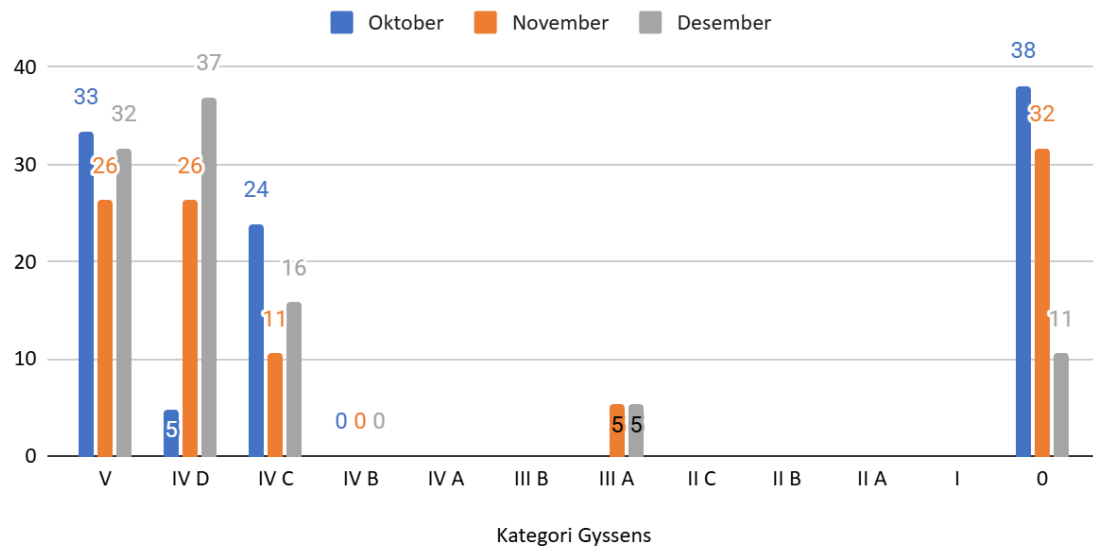
a. SMF Bedah

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Oktober	November	Desember
1.	Kategori V	33	26	32
2.	Kategori IV D	5	26	37
3.	Kategori IV C	24	11	16
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	0	0	0
7.	Kategori III A	0	5	5
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	38	32	11
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)

SMF BEDAH



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

- Pada triwulan IV, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan Oktober sebesar 38%. Namun, masih belum ada persentase dari ketiga bulan tersebut yang memenuhi standar.

-
2. Kategori III A pada SMF Bedah terdapat di bulan November dan Desember dengan prosentase sebesar 6% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu panjang.
 3. Kategori IV C terdapat pada SMF Bedah sebesar 24% dibulan Oktober yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 4. Kategori IV D terdapat pada SMF Bedah sebesar 37% dibulan Desember yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 5. Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 33% dibulan Oktober yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut
 - Untuk SMF Bedah, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

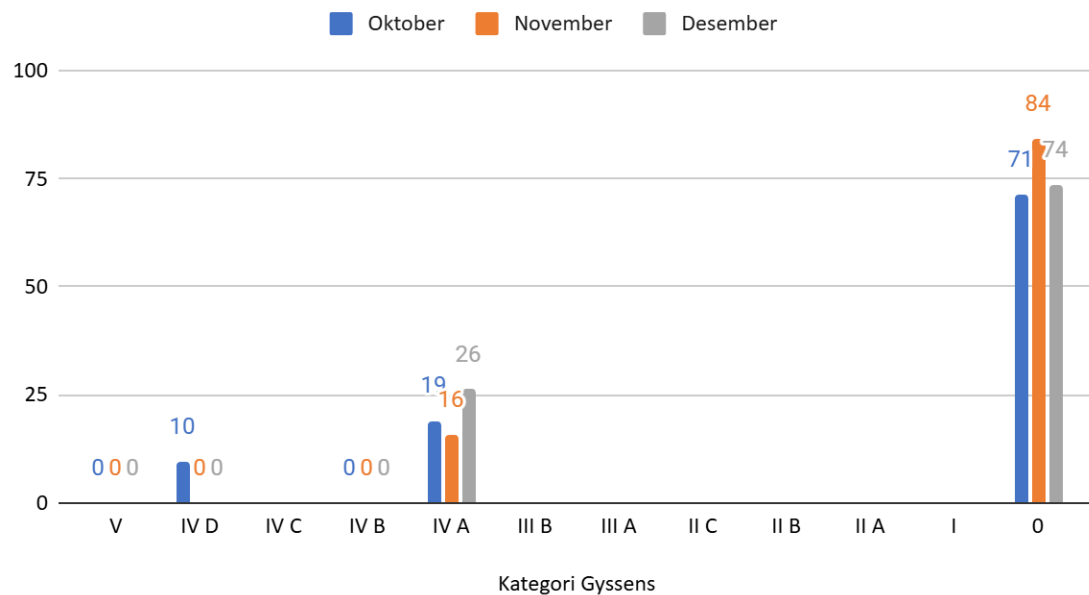
b. SMF Obgyn

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Oktober	November	Desember
1.	Kategori V	0	0	0
2.	Kategori IV D	10	0	0
3.	Kategori IV C	0	0	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	19	16	26
6.	Kategori III B	0	0	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	71	84	74
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

SMF OBGYN



- Analisa penggunaan antibiotik secara kualitatif (Gyssens)

- Pada SMF Obgyn terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase tertinggiya 84% pada bulan November. Hasil tersebut memenuhi standart yaitu perolehan persentase kategori 0 $\geq$ 50%.
- Kategori IV A, ada pada bulan Desember dengan prosentase terbesar yaitu 26% yang

-
- menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif
3. Kategori IV D terdapat pada SMF Obgyn sebesar 10% dibulan Oktober yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
- Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada triwulan IV seluruhnya telah mencapai standar. Masih terdapat beberapa kategori lain seperti kategori IV A yaitu pemilihan antibiotik yang tidak efektif, dan IV D yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya. Namun, persentasenya kecil sehingga perlu dipertahankan dan diperbaiki.

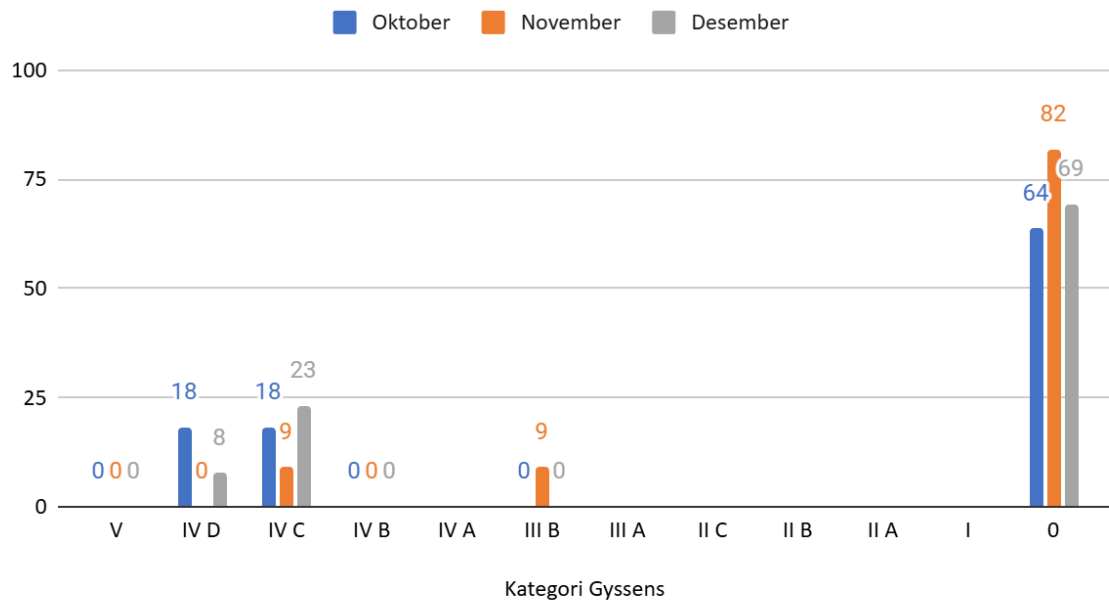
c. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Oktober	November	Desember
1.	Kategori V	0	0	0
2.	Kategori IV D	18	0	8
3.	Kategori IV C	18	9	23
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	0	9	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	64	82	69
Total		100	100	100

- Grafik audit antibiotik SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung secara kualitatif (Gyssens)

SMF IPD, PARU, SYARAF, JANTUNG



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
 - Pada triwulan IV, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan November sebesar 82%. Pada

triwulan IV ini, ketiga bulan telah memenuhi standar yaitu kategori 0 > 50%

2. Kategori III B, prosentase sebesar 9% dibulan November yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.
 3. Kategori IV C paling tinggi terdapat prosentase sebesar 23% dibulan Desember yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 4. Kategori IV D, yaitu pemilihan antibiotik yang kurang tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya, terdapat prosentase yang paling tinggi yaitu 18% pada bulan Oktober.
- Rencana tindak lanjut
Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada bulan November telah mencapai standar. Namun tetap ada pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukkan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV C dan IV D. Sehingga tetap perlu adanya perbaikan untuk berikutnya.

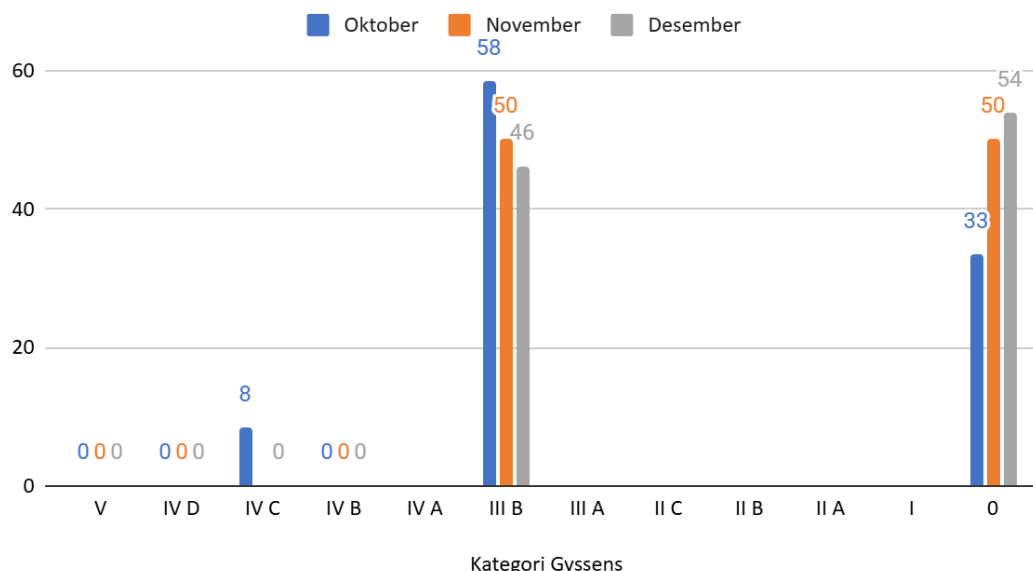
d. SMF Anak

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Anak secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Oktober	November	Desember
1.	Kategori V	0	0	0
2.	Kategori IV D	0	0	0
3.	Kategori IV C	8	0	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	58	50	46
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	33	50	54
Total		100	100	100

- Grafik audit antibiotik SMF Anak secara kualitatif (Gyssens)

SMF ANAK



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
 - Pada triwulan IV, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 54%.
 - Kategori III B, dengan prosentase sebesar 58% terbesar dibulan Oktober yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.
 - Kategori IV C terdapat prosentase 8% dibulan Oktober yang menunjukkan pilihan

antibiotik kurang tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah

- Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Anak, terdapat persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) dengan prosentase tertinggi 54%. Terdapat juga pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukkan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV A, IV C dan V. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk triwulan berikutnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Meningkatkan persepsian antibiotik rasional >50%. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: • Melakukan sosialisasi secara rutin dan terus-menerus • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik rasional oleh tim PPRA.	1. Mengamati pelanggaran DPJP terhadap PPAB 2. Menelusuri penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dengan pendekatan secara personal.	DPJP diajak berdiskusi untuk membentuk PPAB yang sesuai dengan PPK yang betul-betul disepakati.	Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: 1. melakukan sosialisasi secara rutin dan terus menerus

3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025

Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.

4. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan IV Tahun 2025

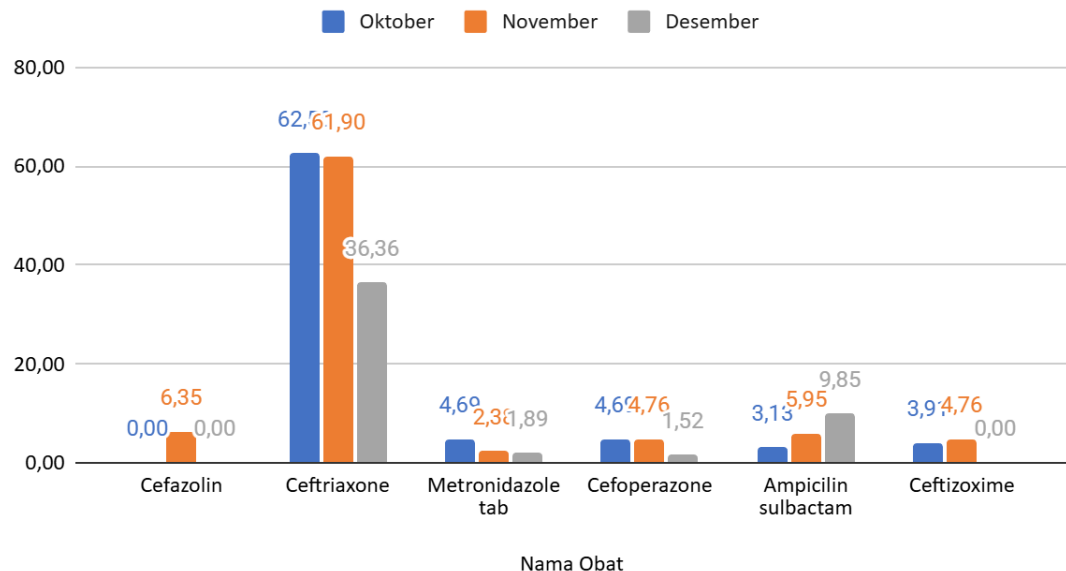
a. SMF Bedah

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Oktober	November	Desember
1.	Cefazolin	0,00	6,35	0,00
2.	Ceftriaxone	62,50	61,90	36,36
3.	Metronidazole tab	4,69	2,38	1,89
4.	Cefoperazone	4,69	4,76	1,52
5.	Ampicilin sulbactam	3,13	5,95	9,85
6.	Ceftizoxime	3,91	4,76	0,00

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF BEDAH



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF bedah

Penggunaan antibiotik pada triwulan IV tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole tab, Ampicilin sulbactam, Cefazolin, Cefoperazone. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Oktober sebesar 62,50 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Malang.

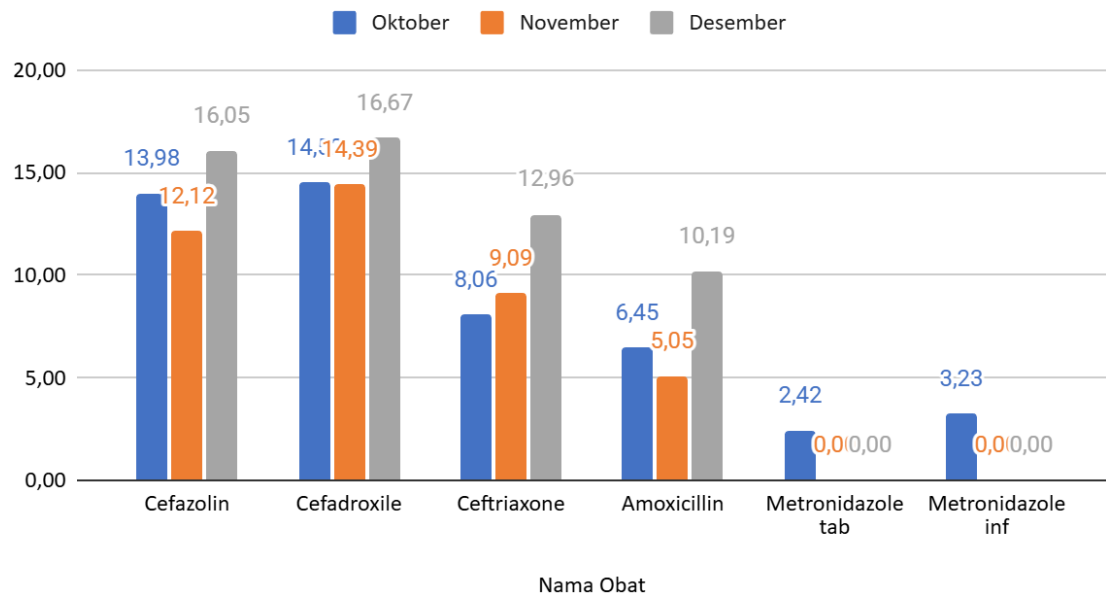
b. SMF Obgyn

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF obgyn secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Oktober	November	Desember
1.	Cefazolin	13,98	12,12	16,05
2.	Cefadroxile	14,52	14,39	16,67
3.	Ceftriaxone	8,06	9,09	12,96
4.	Amoxicillin	6,45	5,05	10,19
5.	Metronidazole tab	2,42	0,00	0,00
6.	Metronidazole inf	3,23	0,00	0,00

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF obgyn

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF OBGYN



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF obgyn

Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin, Cefadroxile, Ceftriaxone, Amoxicillin, Metronidazole tab, dan Metronidazole infus. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefadroxile. Nilai DDD/100 Cefadroxile tertinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 16,67 DDD/100 hari rawat inap.

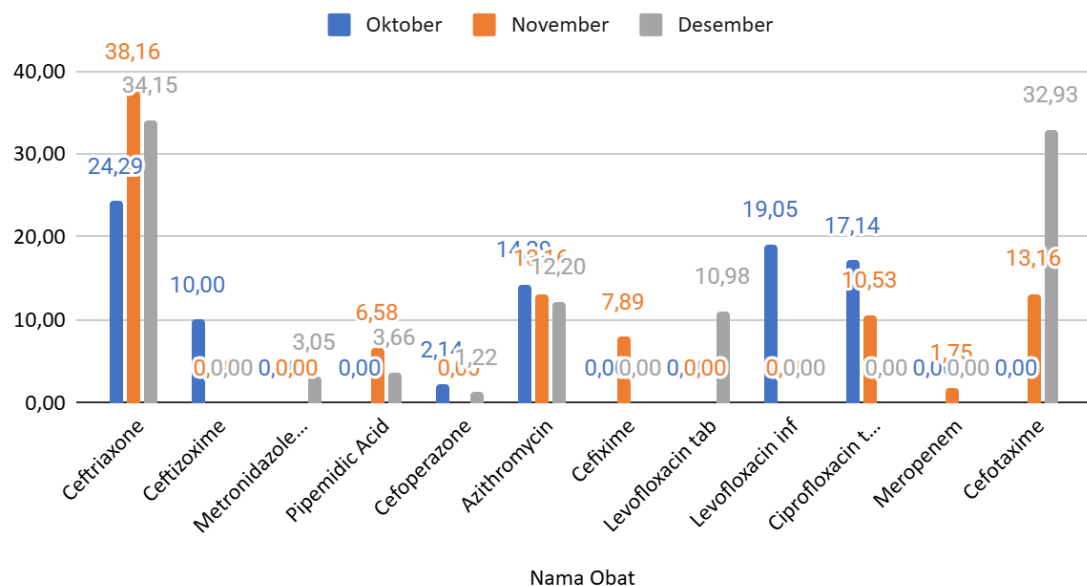
c. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Oktober	November	Desember
1.	Ceftriaxone	24,29	38,16	34,15
2.	Ceftizoxime	10,00	0,00	0,00
3.	Metronidazole tab	0,00	0,00	3,05
4.	Pipemidic Acid	0,00	6,58	3,66
5.	Cefoperazone	2,14	0,00	1,22
6.	Azithromycin	14,29	13,16	12,20
7.	Cefixime	0,00	7,89	0,00
8.	Levofloxacin tab	0,00	0,00	10,98
9.	Levofloxacin inf	19,05	0,00	0,00
10.	Ciprofloxacin tab	17,14	10,53	0,00
11.	Meropenem	0,00	1,75	0,00
12.	Cefotaxime	0,00	13,16	32,93

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD PARU, JANTUNG, SYARAF



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf pada triwulan IV terdiri dari 12 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan Mei dengan nilai 38,16 DDD/100 hari rawat inap.

VII. KESIMPULAN

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada pada triwulan IV tahun 2025 paling banyak terjadi pada bulan November yakni sebesar 73,34%.
2. Penggunaan antibiotik tepat dan rasional yang memenuhi target pada setiap bulan dalam pelaporan triwulan III hanya pada SMF Obgyn dan SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Pada SMF Anak penggunaan antibiotik tepat dan rasional yang memenuhi terdapat pada bulan November dan Desember, namun belum memenuhi pada bulan Oktober. Sementara pada SMF Bedah penggunaan antibiotik tepat dan rasional masih belum memenuhi standar.
3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotik 2025 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.
4. Penggunaan antibiotik terbanyak oleh SMF Bedah dan SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf pada triwulan III tahun 2025 adalah antibiotik Ceftriaxone sebesar 62,50 dan 38,16 DDD/100 hari rawat inap. Pada SMF Obgyn antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Cefadroxile dengan nilai 16,67 DDD/100 hari rawat inap

Malang, 02 Januari 2026

Penyusun,

Ketua Komite PPRA



dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.

Mengetahui,

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes